

MEDIAPP

Diagramas de casos de uso

Presentado por:

ÁNGEL JESÚS HERNÁNDEZ ARÉVALO

RICHARD ALBERTO QUIÑONES QUIÑONES

Ficha 3115426

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
1.1 Notación empleada.....	3
2. Actores del sistema	5
3. Diagrama general de casos de uso	6
4. Diagramas por módulo.....	9
4.1 DCU-01. Autenticación y sesión	10
4.2 DCU-02. Gestión de usuarios	12
4.3 DCU-03. Gestión de médicos	14
4.4 DCU-04. Gestión de pacientes.....	16
4.5 DCU-05. Agendamiento de citas	18
4.6 DCU-06. Historia clínica	20
4.7 DCU-07. Consultas y diagnósticos	22
4.8 DCU-08. Prescripciones	24
4.9 DCU-09. Exámenes de laboratorio	26
4.10 DCU-10. Catálogos.....	28
5. Matriz de casos de uso por actor.....	30

1. Introducción

Este documento reúne los diagramas de casos de uso de MediApp. Un caso de uso describe un objetivo que un actor persigue en el sistema y no una operación sobre la base de datos, de manera que el catálogo se lee como aquello que el sistema permite hacer y no como la lista de sus pantallas. Por esa razón hay 60 casos de uso frente a los ochenta y siete requisitos funcionales especificados, ya que un mismo objetivo suele apoyarse en varios requisitos.

Los casos se organizan en 10 diagramas de módulo, más un diagrama general que resume el sistema completo. La organización coincide con la del documento de requisitos, y esa coincidencia es intencional, porque cada caso declara los requisitos que realiza y permite comprobar que ningún requisito quedó sin caso y que ningún caso describe algo que no fue especificado.

Los tres actores humanos del sistema aparecen en el diagrama general y en los diagramas de los módulos en que intervienen, incluidos aquellos en los que solo consultan. Representar también al lector es necesario en un sistema cuyo propósito es repartir el acceso, porque un diagrama en el que únicamente aparece quien escribe deja sin mostrar la mitad de las reglas.

1.1 Notación empleada

Los diagramas siguen la notación del Lenguaje Unificado de Modelado. Los elementos utilizados son los siguientes.

- **Actor:** figura de palotes situada fuera de la frontera del sistema. Representa un rol y no a una persona concreta, de modo que una misma persona podría actuar como dos actores distintos si tuviera dos cuentas.
- **Caso de uso:** elipse situada dentro de la frontera, rotulada con el objetivo que persigue el actor.

- **Frontera del sistema:** rectángulo que separa lo que el sistema hace de quienes se lo piden.
- **Asociación:** línea continua entre un actor y un caso de uso, que indica que ese actor participa en él.
- **Inclusión:** flecha discontinua rotulada «include», dirigida del caso base al caso incluido. Significa que el caso base no puede completarse sin el incluido, y se usa para no repetir en varios casos un comportamiento que es obligatorio en todos ellos.
- **Extensión:** flecha discontinua rotulada «extend», dirigida del caso que extiende hacia el caso base. Significa que el primero ocurre a veces sobre el segundo, sin que su ausencia impida que el segundo termine.

Los casos que no tienen ningún actor asociado corresponden al actor Sistema, y son reglas que se ejecutan como parte de otro caso sin que nadie las solicite. Se representan como elipses sin línea de asociación, y en todos los diagramas aparecen como destino de una relación de inclusión, que es exactamente lo que son.

La distinción entre inclusión y extensión merece una aclaración, porque es la que más se confunde. La validación de las reglas de la agenda se modela como inclusión y no como extensión, ya que una cita que no pasa por ella no llega a existir. La cancelación de una cita, en cambio, se modela como extensión de la consulta de las citas propias, porque el paciente entra a mirar lo que tiene y puede salir sin cancelar nada.

2. Actores del sistema

El sistema reconoce tres actores humanos, que corresponden a los tres roles de acceso, y un cuarto actor no humano al que se atribuyen las reglas automáticas. La separación entre los tres primeros no es una organización del menú, porque se comprueba en el servidor en cada operación y es lo que sostiene el tercer objetivo específico del proyecto.

Tabla 1

Actores del sistema y alcance de su participación

Actor	Descripción
Administrador	Persona que gestiona la operación del centro de salud. Administra los usuarios, los médicos, los pacientes y los catálogos, controla la agenda completa y carga los resultados de los exámenes de laboratorio. Su única restricción es que no crea ni modifica historias clínicas, consultas ni recetas, aunque sí puede consultarlas.
Médico	Profesional que presta la atención. Es el único actor que puede escribir sobre el acto clínico, esto es, la historia clínica, el diagnóstico con su tratamiento y la prescripción, y además solicita los exámenes de laboratorio. Consulta su agenda pero no la modifica, porque quien agenda es el administrador o el propio paciente.
Paciente	Persona que recibe la atención. Consulta lo que le pertenece, que son sus citas, su historia clínica, sus diagnósticos, sus recetas y sus exámenes. Tiene dos capacidades de escritura, ambas sobre su propia cita, que son reservarla desde el calendario de disponibilidad y cancelarla.
Sistema	Actor no humano al que se atribuyen las reglas que se ejecutan sin que nadie las solicite, como la validación de los conflictos de la agenda, la reserva del turno y la comprobación del rol en cada operación. No se dibuja como figura porque no inicia ningún caso, y sus casos aparecen sin línea de asociación.

Nota. Elaboración propia, a partir de la matriz de permisos acordada con el autor del proyecto.

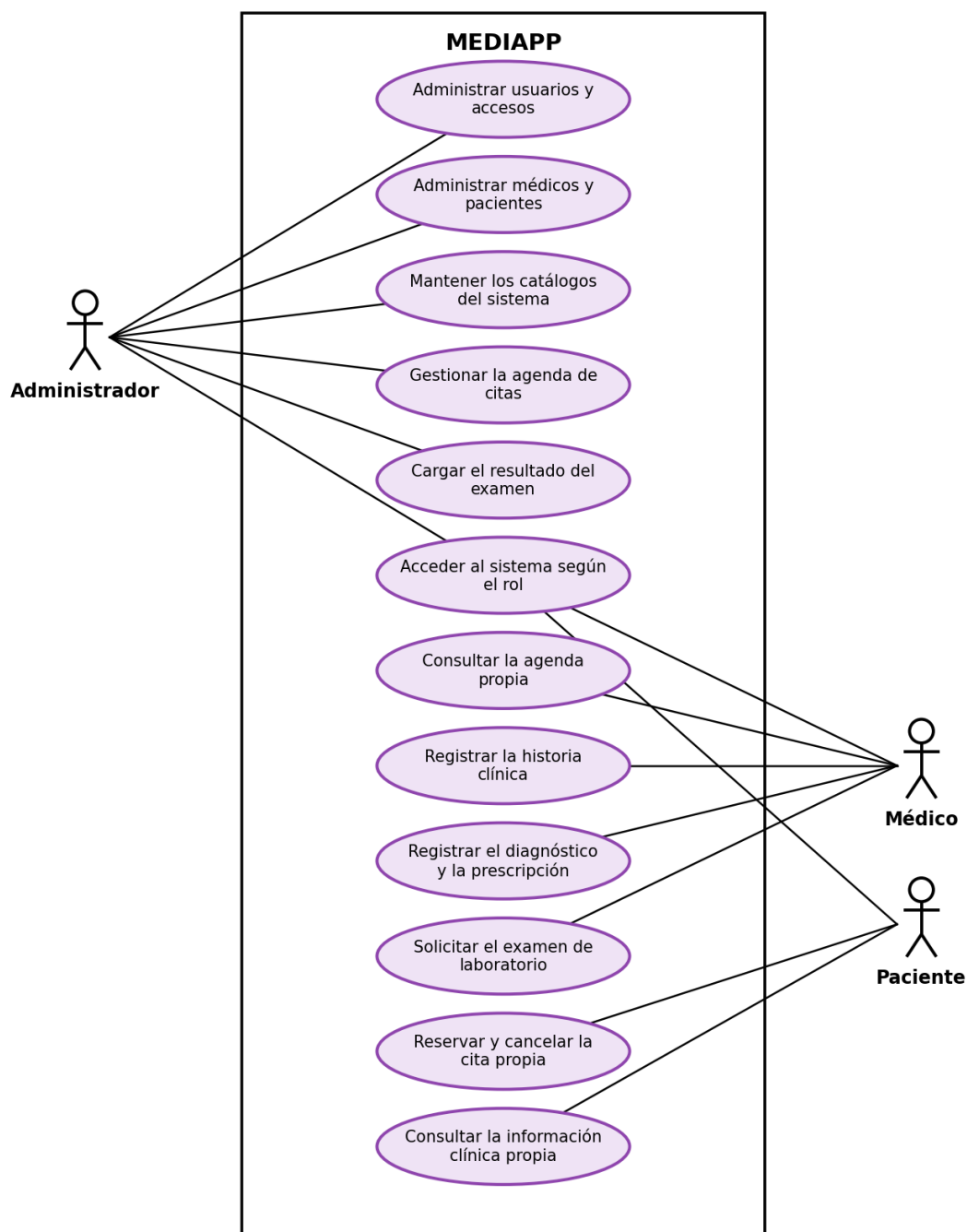
Conviene señalar lo que el reparto tiene de particular, porque no es el de un sistema de gestión corriente. El administrador puede hacer prácticamente todo salvo escribir en la historia clínica, y el médico, que es quien menos pantallas tiene, es el único que puede hacerlo. Esa inversión responde a que el acto clínico pertenece a quien presta la atención y no a quien administra el centro de salud.

3. Diagrama general de casos de uso

El diagrama general presenta el sistema completo agrupando los casos por el propósito que atienden, y cada uno de esos grupos se detalla después en su propio diagrama. Se presenta de esta forma porque un diagrama con los 60 casos y todas sus asociaciones resultaría ilegible, y un diagrama que no se lee no cumple la función de comunicar el alcance del sistema.

Figura 1

Diagrama general de casos de uso de MediApp



Nota. Elaboración propia. Cada elipse agrupa los casos de uso de uno o varios módulos, detallados en el capítulo 4.

Tres observaciones sobre lo que el diagrama muestra. La primera es que el paciente no aparece únicamente como destinatario de la atención, sino iniciando la reserva y la cancelación de su propia cita, que es una decisión de diseño del proyecto y se justifica en el capítulo de análisis del documento de grado. La segunda es que el médico aparece consultando su agenda pero no gestionándola, lo que corresponde a su situación real, ya que nunca agenda ni modifica sus propias citas.

La tercera es la que más dice del sistema. El registro de la historia clínica, del diagnóstico y de la prescripción se conecta con un solo actor, y el administrador, que en todos los demás grupos aparece como el actor principal, no tiene línea hacia ninguno de ellos. Esa ausencia no es un olvido del diagrama sino la restricción central del proyecto dibujada.

4. Diagramas por módulo

Los 10 diagramas siguientes corresponden a los diez módulos funcionales especificados en el documento de requisitos. Cada uno se acompaña de la tabla de sus casos, en la que se indican los actores que participan, los requisitos que el caso realiza y las tablas del modelo de datos sobre las que opera.

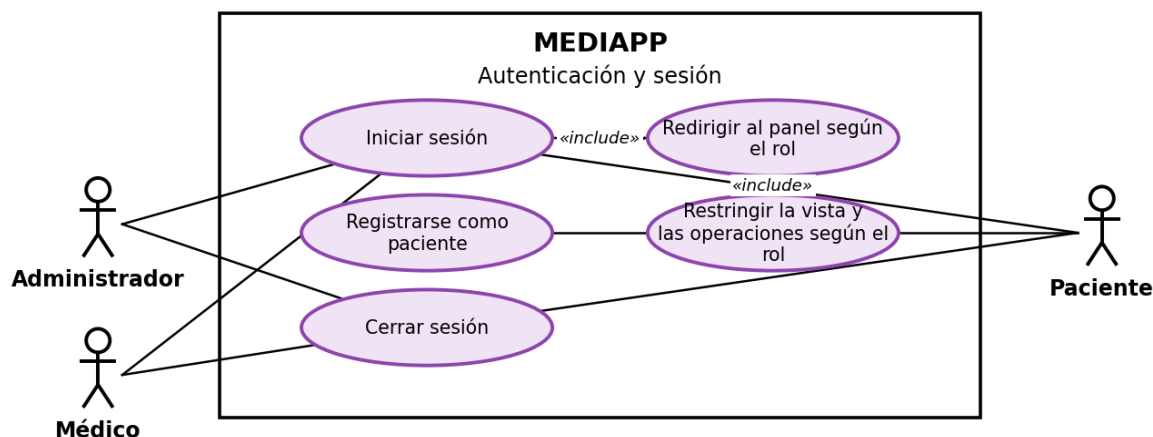
La columna de tablas responde a una exigencia expresa de los evaluadores del proyecto, que pidieron que los casos de uso fueran trazables al modelo de datos. Se presenta con los nombres de las tablas y sin sentencias de consulta, porque los propios evaluadores observaron que en los casos de uso no debe ir código.

4.1 DCU-01. Autenticación y sesión

Recoge la entrada al sistema y el reparto de lo que cada quien ve. La redirección al panel se modela como caso incluido porque no es una decisión aparte, ya que un ingreso que no lleva a ningún tablero no ha terminado, y la restricción por rol se incluye a su vez porque el panel no puede armarse sin saber qué módulos tiene permitidos quien acaba de entrar. Esa misma restricción la incluye toda operación de los demás diagramas, y se omite de ellos para no volverlos ilegibles.

Figura 2

Diagrama de casos de uso del módulo de autenticación y sesión



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 1 del documento de requisitos.

Tabla 2

Casos de uso del módulo DCU-01

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-01	Iniciar sesión	Administrador, Médico, Paciente	RF 1.1, RF 1.3	usuario, rol
CU-02	Redirigir al panel según el rol	Sistema	RF 1.2	usuario, rol
CU-03	Registrarse como paciente	Paciente	RF 1.4, RF 1.5	usuario, rol, paciente

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-04	Cerrar sesión	Administrador, Médico, Paciente	RF 1.7	Ninguna
CU-05	Restringir la vista y las operaciones según el rol	Sistema	RF 1.6, RF 1.8, RF 1.9	usuario, rol

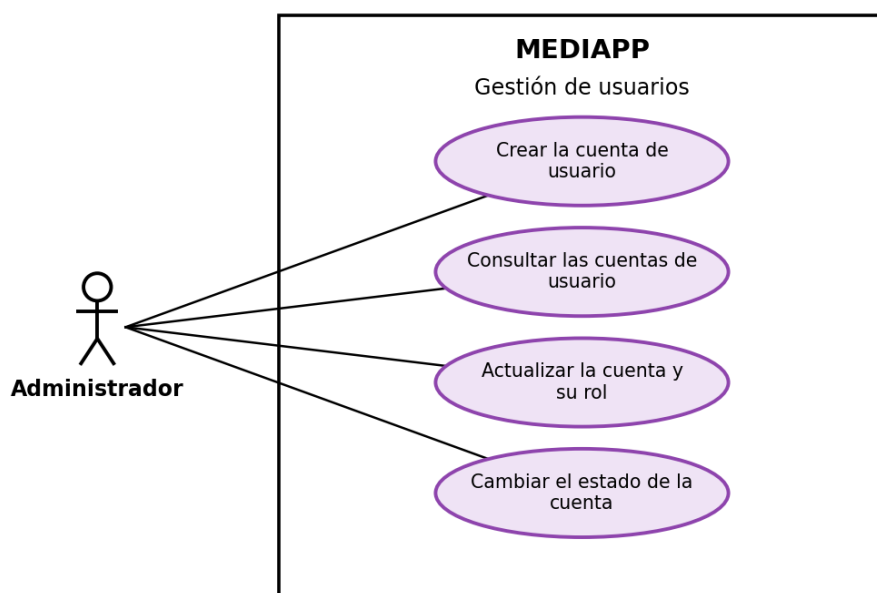
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.2 DCU-02. Gestión de usuarios

Reúne la administración de las cuentas de acceso. Todos sus casos corresponden a un mismo actor porque decidir de qué es capaz cada persona es una atribución exclusiva del administrador, y por eso no hay aquí relaciones de inclusión ni de extensión.

Figura 3

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de usuarios



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 2 del documento de requisitos.

Tabla 3

Casos de uso del módulo DCU-02

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-06	Crear la cuenta de usuario	Administrador	RF 2.1, RF 2.7	usuario, rol
CU-07	Consultar las cuentas de usuario	Administrador	RF 2.2, RF 2.8	usuario, rol
CU-08	Actualizar la cuenta y su rol	Administrador	RF 2.3, RF 2.4, RF 2.7	usuario, rol

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-09	Cambiar el estado de la cuenta	Administrador	RF 2.5, RF 2.6	usuario

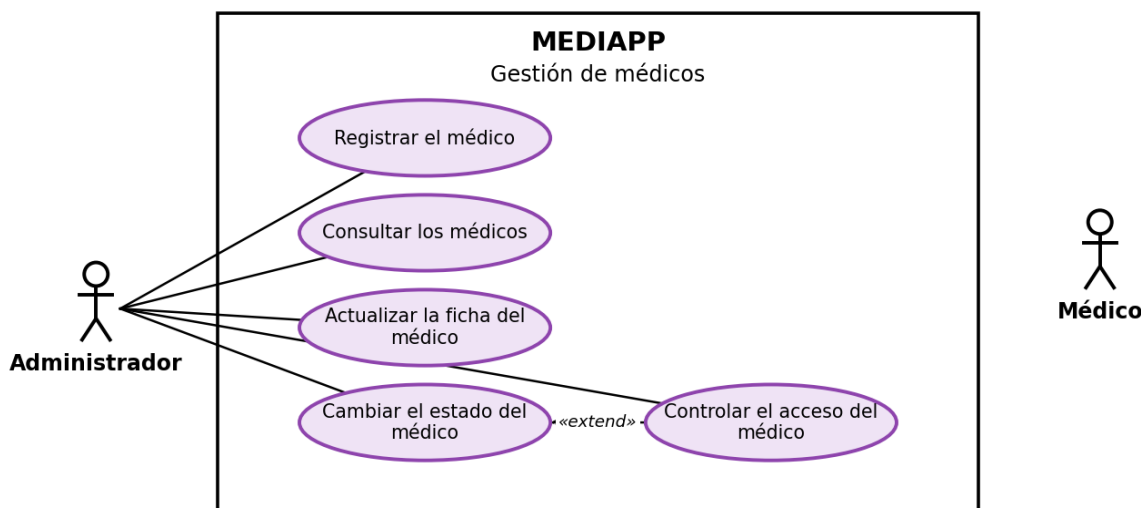
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.3 DCU-03. Gestión de médicos

Cubre la ficha profesional del médico y su vínculo con la cuenta con la que ingresa, que se administra en el diagrama anterior. El control del acceso extiende el cambio de estado, porque suspender el ingreso de un médico y darlo de baja de la agenda son dos decisiones distintas que no siempre se toman juntas, ya que un profesional puede seguir recibiendo citas mientras se le retira temporalmente el acceso al sistema.

Figura 4

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de médicos



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 3 del documento de requisitos.

Tabla 4

Casos de uso del módulo DCU-03

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-10	Registrar el médico	Administrador	RF 3.1, RF 3.7	medico, usuario, especialidad
CU-11	Consultar los médicos	Administrador	RF 3.2, RF 3.8	medico, especialidad
CU-12	Actualizar la ficha del médico	Administrador	RF 3.3	medico, especialidad

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-13	Cambiar el estado del médico	Administrador	RF 3.4, RF 3.5	medico
CU-14	Controlar el acceso del médico	Administrador	RF 3.6	medico, usuario

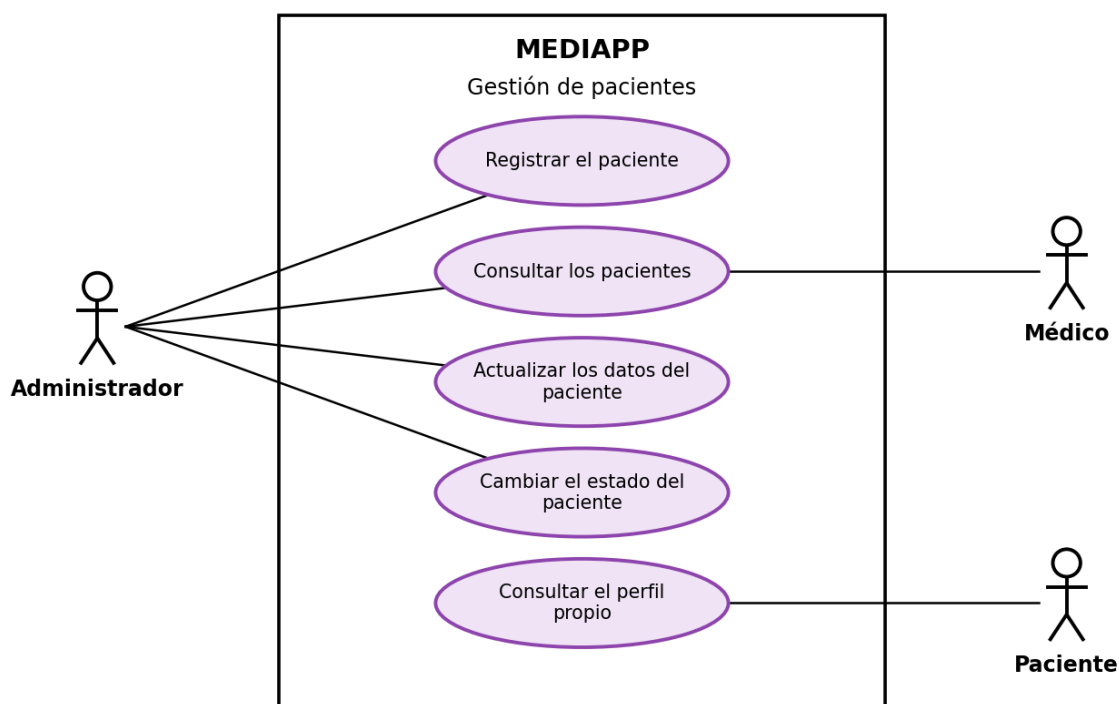
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.4 DCU-04. Gestión de pacientes

Cubre el registro y el mantenimiento de las personas que reciben atención. Aparecen los tres actores con alcances distintos, ya que el administrador gestiona, el médico únicamente consulta el directorio para ubicar a quien atiende y el paciente solo ve su propio perfil.

Figura 5

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de pacientes



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 4 del documento de requisitos.

Tabla 5

Casos de uso del módulo DCU-04

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-15	Registrar el paciente	Administrador	RF 4.1, RF 4.7, RF 4.8	paciente, usuario
CU-16	Consultar los pacientes	Administrador, Médico	RF 4.2, RF 4.3	paciente

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-17	Actualizar los datos del paciente	Administrador	RF 4.4	paciente
CU-18	Cambiar el estado del paciente	Administrador	RF 4.5, RF 4.6	paciente
CU-19	Consultar el perfil propio	Paciente	RF 4.9	paciente, usuario

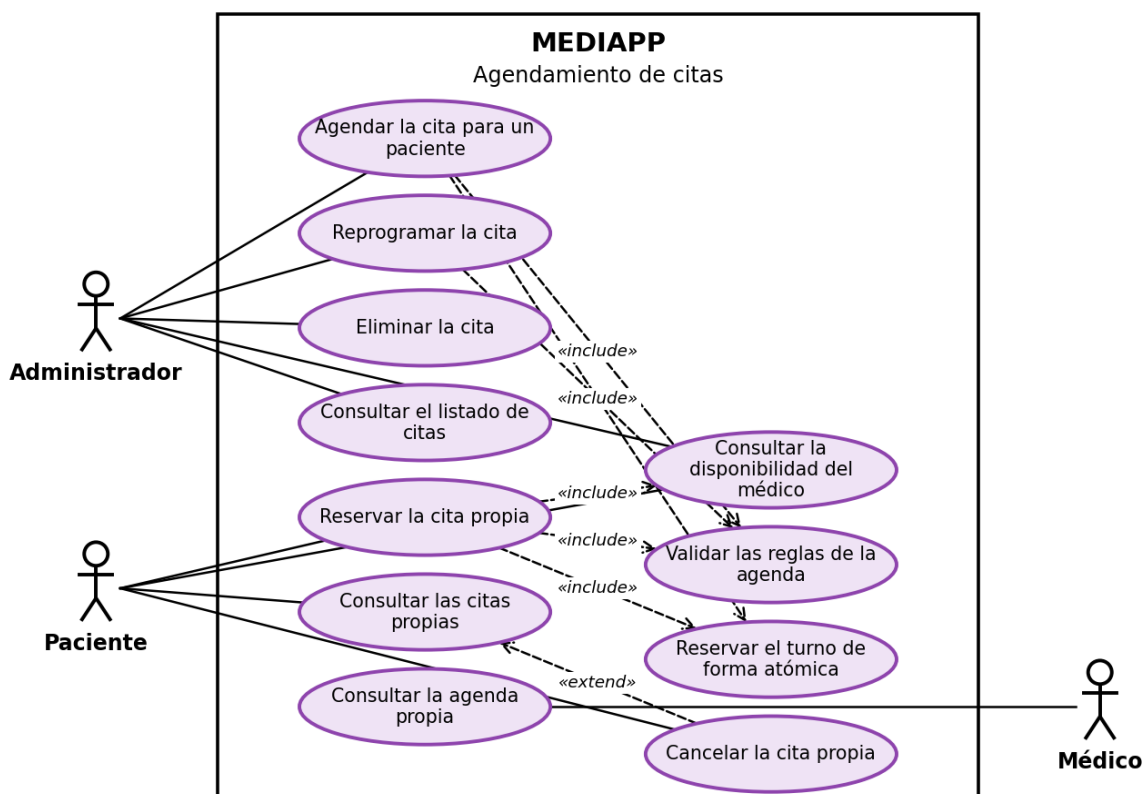
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.5 DCU-05. Agendamiento de citas

Es el núcleo del sistema. Los tres casos que escriben en la agenda comparten las condiciones que hacen válida a una cita, que son la validación de las reglas y la reserva del turno, y por eso se modelan como casos incluidos en lugar de repetirse en cada uno. La reserva de la cita propia incluye además la consulta de disponibilidad, porque el paciente no dispone de un formulario donde elegir la hora y solo puede tomar un horario del calendario, que es lo que impide que agende sobre un turno ocupado. La cancelación, en cambio, extiende la consulta de las citas propias, ya que el paciente entra a mirar lo que tiene y puede salir sin cancelar nada.

Figura 6

Diagrama de casos de uso del módulo de agendamiento de citas



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 5 del documento de requisitos.

Tabla 6*Casos de uso del módulo DCU-05*

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-20	Agendar la cita para un paciente	Administrador	RF 5.1	cita, paciente, medico
CU-21	Reprogramar la cita	Administrador	RF 5.11	cita, paciente, medico
CU-22	Eliminar la cita	Administrador	RF 5.13	cita
CU-23	Consultar el listado de citas	Administrador	RF 5.14	cita, paciente, medico
CU-24	Reservar la cita propia	Paciente	RF 5.2, RF 5.3	cita, paciente, medico
CU-25	Consultar las citas propias	Paciente	RF 5.10	cita, medico
CU-26	Consultar la agenda propia	Médico	RF 5.9	cita, paciente, medico
CU-27	Consultar la disponibilidad del médico	Paciente, Administrador	RF 5.8	cita, medico
CU-28	Validar las reglas de la agenda	Sistema	RF 5.4, RF 5.5, RF 5.7	cita
CU-29	Reservar el turno de forma atómica	Sistema	RF 5.6	cita
CU-30	Cancelar la cita propia	Paciente	RF 5.12	cita

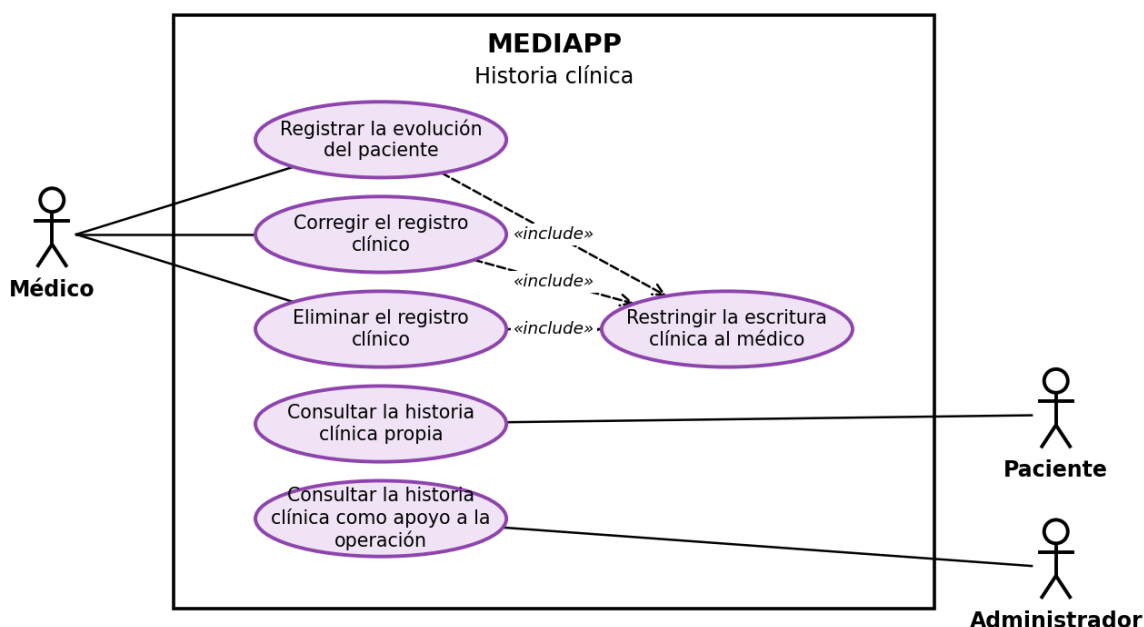
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.6 DCU-06. Historia clínica

Es el diagrama donde se ve la restricción que le da carácter al proyecto. Los tres casos de escritura incluyen la comprobación del rol, que no es una acción que alguien decida ejecutar sino una condición obligatoria de haber intentado escribir, y los dos actores de la derecha aparecen únicamente como lectores.

Figura 7

Diagrama de casos de uso del módulo de historia clínica



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 6 del documento de requisitos.

Tabla 7

Casos de uso del módulo DCU-06

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-31	Registrar la evolución del paciente	Médico	RF 6.1, RF 6.3, RF 6.8	historia, paciente, medico
CU-32	Corregir el registro clínico	Médico	RF 6.4	historia, medico

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-33	Eliminar el registro clínico	Médico	RF 6.5	historia, medico
CU-34	Restringir la escritura clínica al médico	Sistema	RF 6.2	historia, usuario, rol
CU-35	Consultar la historia clínica propia	Paciente	RF 6.6	historia, medico
CU-36	Consultar la historia clínica como apoyo a la operación	Administrador	RF 6.7	historia, paciente, medico

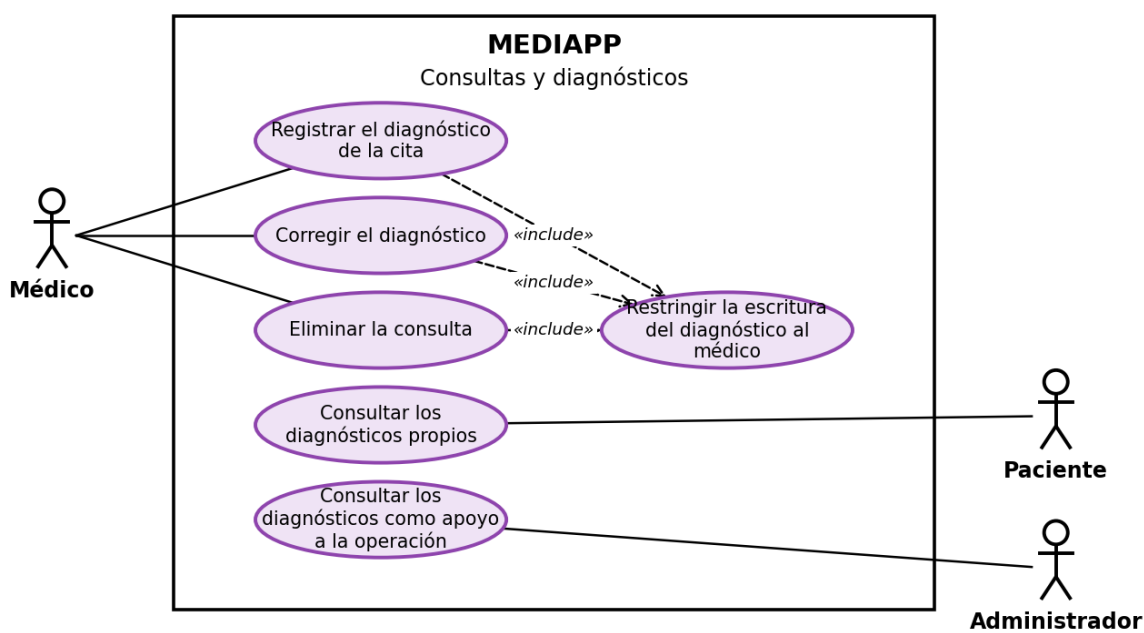
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.7 DCU-07. Consultas y diagnósticos

Repite la estructura del diagrama anterior porque la regla es la misma, y el diagnóstico queda unido a la cita que lo originó. El administrador y el paciente aparecen a la derecha porque leen el resultado del acto clínico sin participar en él.

Figura 8

Diagrama de casos de uso del módulo de consultas y diagnósticos



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 7 del documento de requisitos.

Tabla 8

Casos de uso del módulo DCU-07

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-37	Registrar el diagnóstico de la cita	Médico	RF 7.1, RF 7.6, RF 7.7	consulta, cita, paciente, medico
CU-38	Corregir el diagnóstico	Médico	RF 7.3	consulta, medico
CU-39	Eliminar la consulta	Médico	RF 7.4	consulta, medico
CU-40	Restringir la escritura del diagnóstico al médico	Sistema	RF 7.2	consulta, usuario, rol

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-41	Consultar los diagnósticos propios	Paciente	RF 7.5	consulta, cita, medico
CU-42	Consultar los diagnósticos como apoyo a la operación	Administrador	RF 7.8	consulta, cita, paciente, medico

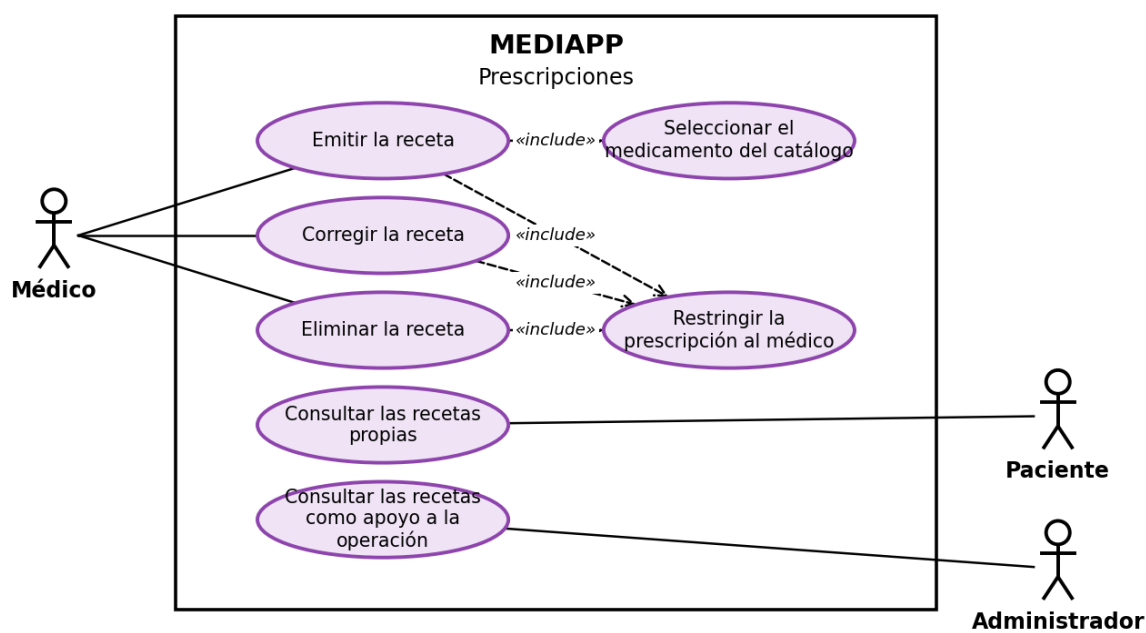
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.8 DCU-08. Prescripciones

Cierra el acto clínico. La selección del medicamento se modela como caso incluido porque el medicamento no se escribe libremente sino que se toma del catálogo vigente, de modo que una receta siempre apunte a un producto que existe.

Figura 9

Diagrama de casos de uso del módulo de prescripciones



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 8 del documento de requisitos.

Tabla 9

Casos de uso del módulo DCU-08

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-43	Emitir la receta	Médico	RF 8.1, RF 8.7	receta, consulta, medicamento, paciente
CU-44	Seleccionar el medicamento del catálogo	Sistema	RF 8.3	medicamento
CU-45	Corregir la receta	Médico	RF 8.4	receta, medicamento
CU-46	Eliminar la receta	Médico	RF 8.5	receta, consulta

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-47	Restringir la prescripción al médico	Sistema	RF 8.2	receta, usuario, rol
CU-48	Consultar las recetas propias	Paciente	RF 8.6	receta, medicamento, consulta
CU-49	Consultar las recetas como apoyo a la operación	Administrador	RF 8.8	receta, medicamento, paciente

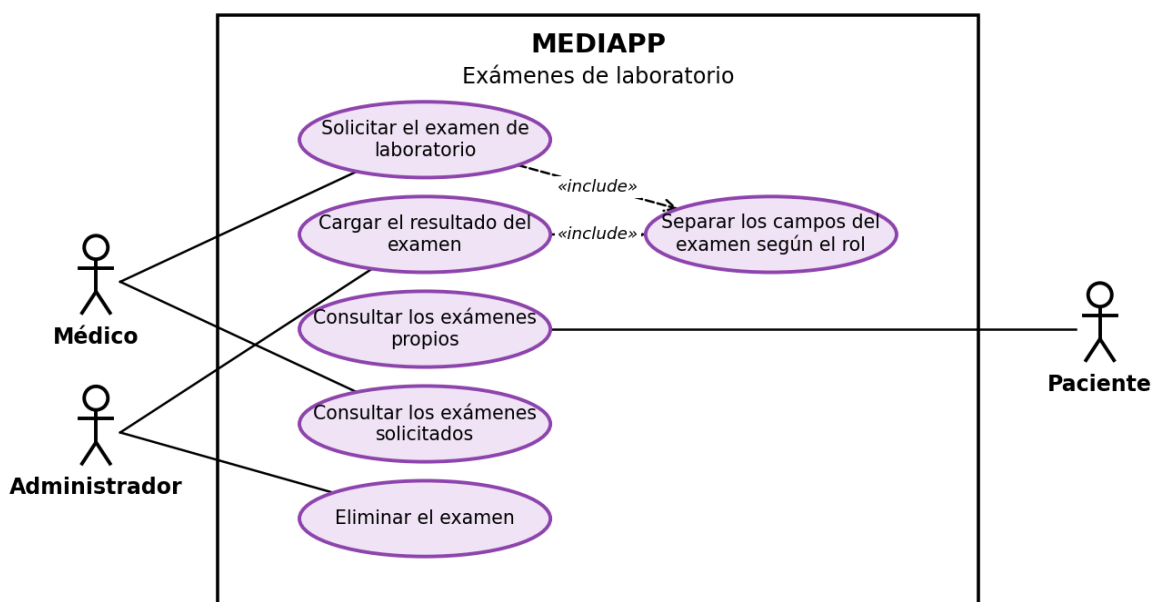
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.9 DCU-09. Exámenes de laboratorio

Es el único diagrama con dos actores escribiendo sobre la misma fila, porque solicitar el examen y resolverlo son dos actos de dos personas distintas. La separación de los campos se incluye en ambos casos, ya que es lo que impide que el médico escriba un resultado o que el administrador modifique la solicitud.

Figura 10

Diagrama de casos de uso del módulo de exámenes de laboratorio



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 9 del documento de requisitos.

Tabla 10

Casos de uso del módulo DCU-09

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-50	Solicitar el examen de laboratorio	Médico	RF 9.1, RF 9.7	examen, paciente, medico
CU-51	Cargar el resultado del examen	Administrador	RF 9.2	examen

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-52	Separar los campos del examen según el rol	Sistema	RF 9.3	examen, usuario, rol
CU-53	Consultar los exámenes propios	Paciente	RF 9.4	examen, medico
CU-54	Consultar los exámenes solicitados	Médico	RF 9.5	examen, paciente
CU-55	Eliminar el examen	Administrador	RF 9.6	examen

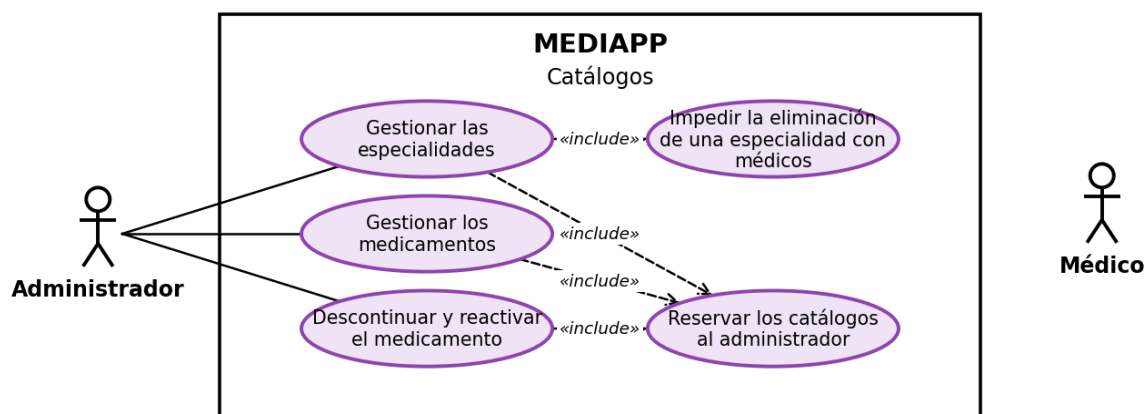
Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

4.10 DCU-10. Catálogos

Reúne los datos que se ajustan de vez en cuando y que después alimentan los formularios de todos los días. El médico aparece a la derecha sin pantalla propia de catálogo, porque el único lugar donde necesita ver los medicamentos es el selector del formulario de recetas, que pertenece al diagrama de prescripciones.

Figura 11

Diagrama de casos de uso del módulo de catálogos



Nota. Elaboración propia. Corresponde al módulo RF 10 del documento de requisitos.

Tabla 11

Casos de uso del módulo DCU-10

Código	Caso de uso	Actores	Requisitos	Tablas que toca
CU-56	Gestionar las especialidades	Administrador	RF 10.1, RF 10.2	especialidad
CU-57	Impedir la eliminación de una especialidad con médicos	Sistema	RF 10.3	especialidad, medico
CU-58	Gestionar los medicamentos	Administrador	RF 10.4, RF 10.5	medicamento
CU-59	Descontinuar y reactivar el medicamento	Administrador	RF 10.6, RF 10.7	medicamento, receta
CU-60	Reservar los catálogos al administrador	Sistema	RF 10.8	especialidad, medicamento, usuario, rol

Nota. Elaboración propia. Los casos atribuidos al Sistema son casos incluidos, que se ejecutan como parte de otro y que nadie inicia por separado.

5. Matriz de casos de uso por actor

La matriz resume en qué casos participa cada actor. Sirve para comprobar dos cosas, que ningún actor quedó sin casos, lo que indicaría un rol declarado pero no utilizado, y que ningún caso quedó sin actor salvo los incluidos, que por definición los ejecuta el sistema.

Tabla 12

Matriz de participación de los actores en los casos de uso

Código	Caso de uso	Administrador	Médico	Paciente	Sistema
CU-01	Iniciar sesión	X	X	X	
CU-02	Redirigir al panel según el rol				X
CU-03	Registrarse como paciente			X	
CU-04	Cerrar sesión	X	X	X	
CU-05	Restringir la vista y las operaciones según el rol				X
CU-06	Crear la cuenta de usuario	X			
CU-07	Consultar las cuentas de usuario	X			
CU-08	Actualizar la cuenta y su rol	X			
CU-09	Cambiar el estado de la cuenta	X			
CU-10	Registrar el médico	X			
CU-11	Consultar los médicos	X			
CU-12	Actualizar la ficha del médico	X			
CU-13	Cambiar el estado del médico	X			
CU-14	Controlar el acceso del médico	X			
CU-15	Registrar el paciente	X			
CU-16	Consultar los pacientes	X	X		
CU-17	Actualizar los datos del paciente	X			
CU-18	Cambiar el estado del paciente	X			
CU-19	Consultar el perfil propio			X	
CU-20	Agendar la cita para un paciente	X			
CU-21	Reprogramar la cita	X			
CU-22	Eliminar la cita	X			
CU-23	Consultar el listado de citas	X			
CU-24	Reservar la cita propia			X	
CU-25	Consultar las citas propias			X	
CU-26	Consultar la agenda propia		X		
CU-27	Consultar la disponibilidad del médico	X		X	
CU-28	Validar las reglas de la agenda				X
CU-29	Reservar el turno de forma atómica				X
CU-30	Cancelar la cita propia			X	
CU-31	Registrar la evolución del paciente		X		
CU-32	Corregir el registro clínico		X		
CU-33	Eliminar el registro clínico		X		

Código	Caso de uso	Administrador	Médico	Paciente	Sistema
CU-34	Restringir la escritura clínica al médico				X
CU-35	Consultar la historia clínica propia			X	
CU-36	Consultar la historia clínica como apoyo a la operación	X			
CU-37	Registrar el diagnóstico de la cita		X		
CU-38	Corregir el diagnóstico		X		
CU-39	Eliminar la consulta		X		
CU-40	Restringir la escritura del diagnóstico al médico				X
CU-41	Consultar los diagnósticos propios			X	
CU-42	Consultar los diagnósticos como apoyo a la operación	X			
CU-43	Emitir la receta		X		
CU-44	Seleccionar el medicamento del catálogo				X
CU-45	Corregir la receta		X		
CU-46	Eliminar la receta		X		
CU-47	Restringir la prescripción al médico				X
CU-48	Consultar las recetas propias			X	
CU-49	Consultar las recetas como apoyo a la operación	X			
CU-50	Solicitar el examen de laboratorio		X		
CU-51	Cargar el resultado del examen	X			
CU-52	Separar los campos del examen según el rol				X
CU-53	Consultar los exámenes propios			X	
CU-54	Consultar los exámenes solicitados		X		
CU-55	Eliminar el examen	X			
CU-56	Gestionar las especialidades	X			
CU-57	Impedir la eliminación de una especialidad con médicos				X
CU-58	Gestionar los medicamentos	X			
CU-59	Descontinuar y reactivar el medicamento	X			
CU-60	Reservar los catálogos al administrador				X

Nota. Elaboración propia. La columna Sistema marca los casos sin actor humano, que se ejecutan como parte de otro caso.

De los 60 casos de uso, 11 se atribuyen al actor Sistema y el resto tiene al menos un actor humano. El administrador participa en 28 casos, el médico en 15 y el paciente en 12, de modo que los tres roles declarados intervienen en el sistema y ninguno quedó como un perfil escrito en la documentación pero sin uso.

El reparto de la matriz confirma lo que el diagrama general mostraba. El administrador encabeza el conteo porque gestiona la operación completa, pero no aparece marcado en ninguno de los casos de escritura sobre la historia clínica, la consulta ni la receta, y el médico, que participa en menos casos, es el único marcado en todos ellos.